Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Parotidektomie

Teilweise oder vollständige Entfernung der Ohrspeicheldrüse (Parotis, vor dem Ohr)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links

Geplanter Umfang: ☐ Oberflächlich (superfiziell) ☐ Partiell / extrakapsulär ☐ Total
☐ Wird während der Operation entschieden _____

Neuromonitoring des Gesichtsnervs: ☐ Wird eingesetzt ☐ Wird nicht eingesetzt

Vorläufige Diagnose (Feinnadelbiopsie / Ergebnis der Bildgebung): _____

Im Voraus gemeinsam getroffene Entscheidung, falls der Tumor den Gesichtsnerv erfasst: ☐ Ein Nervenast darf falls nötig geopfert werden ☐ Den Nerv erhalten
☐ Sonstiges _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Ohrspeicheldrüse (Parotis) ist die größte Speicheldrüse. Auf jeder Seite liegt eine vor und knapp unterhalb des Ohres. Der **Gesichtsnerv (Nervus facialis)**, der die Gesichtsmuskulatur bewegt, verläuft durch die Drüse und teilt sich in ihr in seine Äste auf. Die Operation an der Ohrspeicheldrüse ist daher ein feiner Eingriff, bei dem besonders sorgfältig auf den Schutz dieses Nervs geachtet wird.

Eine Parotidektomie wird am häufigsten wegen eines **Knotens (Tumors)** in der Drüse durchgeführt. Die große Mehrheit dieser Knoten (etwa 80 %) ist **gutartig (kein Krebs)**; am häufigsten sind das pleomorphe Adenom und der Warthin-Tumor. Auch gutartige Knoten können mit der Zeit wachsen, und einige (insbesondere das pleomorphe Adenom) können im Laufe vieler Jahre bösartig werden. Seltener ist eine Operation wegen wiederkehrender Entzündungen, Steinen oder eines bösartigen Tumors erforderlich.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ziel der Operation ist es, den Knoten bzw. das erkrankte Drüsengewebe **unter Erhalt des Gesichtsnervs** vollständig zu entfernen und durch die feingewebliche (pathologische) Untersuchung die endgültige Diagnose zu stellen.

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt. Vor der Operation wird der Knoten mit Ultraschall, MRT und/oder Feinnadelbiopsie beurteilt; diese Untersuchungen liefern wertvolle vorläufige Informationen, die endgültige Diagnose wird jedoch nach der Operation durch die Pathologie gestellt.

1. **Hautschnitt:** Der Schnitt beginnt meist in der natürlichen Hautfalte vor dem Ohr, verläuft im Bogen um das Ohrläppchen herum nach unten und setzt sich in einer Hautfalte am Hals fort. In geeigneten Fällen kann der Schnitt kürzer gehalten oder am Haaransatz versteckt werden.
2. **Aufsuchen des Gesichtsnervs:** Die Haut und das Gewebe über der Drüse werden angehoben, und der Hauptstamm des Gesichtsnervs wird dargestellt. Falls eingesetzt, hilft ein **Neuromonitoring**-Gerät, Lage und Funktion des Nervs während der gesamten Operation zu überwachen.
3. **Entfernung des Knotens/der Drüse:** Der Nerv und seine Äste werden sorgfältig verfolgt, während der Knoten zusammen mit einem Saum gesunden Drüsengewebes entfernt wird. Je nach Lage und Größe des Knotens wird nur der äußere Teil der Drüse (oberflächlich), ein Teil davon oder die gesamte Drüse (total) entfernt.
4. **Feingewebliche Untersuchung:** Das entfernte Gewebe wird zur Pathologie geschickt. Das endgültige Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 1–2 Wochen vor.
5. **Wundverschluss:** Blutungen werden gestillt, und meist wird eine dünne **Drainage** (Schlauch) eingelegt, um sich ansammelndes Blut oder Wundflüssigkeit abzuleiten. Die Haut wird mit feinen Nähten verschlossen; gegebenenfalls wird ein leichter Druckverband angelegt.

Wenn der Tumor den Gesichtsnerv umschließt oder in ihn hineingewachsen ist (dies kommt vor allem bei bösartigen Tumoren vor), kann es notwendig sein, einen Ast des Nervs oder den gesamten Nerv zu opfern, um den Tumor vollständig zu entfernen. Diese Möglichkeit wird vor der Operation **gesondert mit Ihnen besprochen**. Der Nerv wird nicht unerwartet durchtrennt, ohne dass dies mit Ihnen besprochen wurde; was geschehen soll, falls sich der Tumor nicht vom Nerv lösen lässt, wird vorab gemeinsam mit Ihnen festgelegt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 2–4 Stunden	In der Regel 1–2 Nächte; Entlassung nach Entfernung der Drainage

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Entfernung des Knotens und Stellung der endgültigen Diagnose
- Verhindern, dass ein gutartiger Knoten wächst, auf den Gesichtsnerv drückt und langfristig bösartig wird
- Bei bösartigen Tumoren der erste und wichtigste Behandlungsschritt
- Beendigung von Schmerzen und Schwellungen durch wiederkehrende Entzündungen oder Steine

Bei den meisten gutartigen Tumoren führt die Operation zur dauerhaften Heilung. Bei pleomorphen Adenomen, die mit geeigneter Technik entfernt wurden, liegt die Rückfallrate **unter 1–2 von 100 Patienten**; ein Einreißen der Tumorkapsel oder eine frühere Operation erhöht diese Rate jedoch. Ein Warthin-Tumor kann als neuer Herd in derselben oder in der gegenüberliegenden Drüse auftreten. Bei bösartigen Tumoren hängt das Ergebnis von Art und Stadium des Tumors ab, und eine weitere Behandlung kann erforderlich sein.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Beobachtung:** Bei manchen kleinen Knoten, die für gutartig gehalten werden (zum Beispiel ein Warthin-Tumor bei älteren Patienten oder bei hohem Operationsrisiko), kann eine regelmäßige Verlaufskontrolle mit Ultraschall/MRT besprochen werden. Der Knoten bleibt dann bestehen und kann wachsen, und eine endgültige Diagnose kann nicht gestellt werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Medikamentöse Behandlung:** Bei Entzündungen oder Steinen – Antibiotika, reichlich Flüssigkeit, Massage; in geeigneten Fällen Entfernung der Steine durch eine Spiegelung des Speichelgangs (Sialendoskopie). Bei Tumoren ist eine medikamentöse Behandlung keine Option.
- **Strahlentherapie:** Wird bei bösartigen Tumoren eingesetzt, die nicht operiert werden können, oder ergänzend zur Operation; bei gutartigen Tumoren ist sie nicht die bevorzugte Behandlung.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation bleibt der Knoten bestehen, und eine endgültige Diagnose kann nicht gestellt werden. Gutartige Tumoren wachsen meist langsam, können sich aber mit der Zeit vergrößern, was die Operation erschwert und das Risiko für den Gesichtsnerv erhöht; pleomorphe Adenome können im Laufe vieler Jahre bösartig werden (über die Jahre etwa 5–10 %). Ein bösartiger Tumor schreitet unbehandelt fort und kann sich auf umliegendes Gewebe und Lymphknoten ausbreiten.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen, eine Bildgebung (Ultraschall/MRT) und bei Bedarf eine Feinnadelbiopsie durchgeführt; Sie werden von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (bitte befolgen Sie die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Bei männlichen Patienten können Bart und Haare um das Ohr im Schnittbereich am Operationstag gekürzt werden. Je nach Schnittführung können auch einige Haare hinter dem Ohr gekürzt werden.
- Ihre Gesichtsbewegungen werden vor der Operation untersucht und fotografiert, um ihre Funktion vor dem Eingriff zu dokumentieren.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24–48 Stunden	Im Operationsgebiet bestehen ein Spannungsgefühl, leichte bis mäßige Schmerzen und eine Schwellung, die mit Schmerzmitteln behandelt werden. Die Drainage wird meist am 1.–2. Tag entfernt, sobald weniger Flüssigkeit abfließt. Es wird empfohlen, mit erhöhtem Kopf zu schlafen. Ihre Gesichtsbewegungen werden kontrolliert.
1. Woche	Nach der Entlassung können Sie Ihren Alltagstätigkeiten wieder nachgehen. Die Fäden werden in der Regel am **5.–7. Tag** gezogen. Ein Taubheitsgefühl am Ohrläppchen und vor dem Ohr ist deutlich spürbar. Das Ergebnis der Pathologie liegt meist in diesem Zeitraum oder kurz danach vor und wird mit Ihnen besprochen.
2.–6. Woche	Die meisten Patienten können innerhalb von 1–2 Wochen wieder einer Bürotätigkeit nachgehen. Anstrengender Sport sowie Arbeiten mit Bücken und Heben sollten etwa **2–3**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Wochen aufgeschoben werden. Falls eine vorübergehende Schwäche der Gesichtsmuskulatur besteht, beginnt sie sich meist innerhalb von Wochen zu bessern; Augenschutz und Gesichtsübungen werden empfohlen.
3.–12. Monat	Die Narbe verblasst allmählich. Das Taubheitsgefühl am Ohrläppchen bessert sich teilweise. Die meisten Patienten mit vorübergehender Nervenschwäche erholen sich innerhalb von 6–12 Monaten vollständig. Ein Schwitzen der Wange beim Essen (Frey-Syndrom) kann, falls es auftritt, in diesem Zeitraum beginnen.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schmerzen, Spannungsgefühl und Schwellung im Operationsgebiet
- Taubheitsgefühl am Ohrläppchen und an der Haut vor dem Ohr
- Eine Narbe an der Schnittstelle (verblasst mit der Zeit)
- Leichte Schmerzen auf der operierten Seite beim Öffnen des Mundes oder beim Kauen (erste Tage)

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Vorübergehende Schwäche des Gesichtsnervs** — Bei etwa **10–40 von 100** Patienten (abhängig davon, wie viel Gewebe entfernt wird und wo der Knoten liegt) tritt eine vorübergehende Schwäche am Mundwinkel, beim Augenschluss oder beim Anheben der Augenbraue auf. Meist ist nur ein Ast betroffen, und die Schwäche **bessert sich innerhalb von Wochen bis Monaten**. Wenn sich Ihr Auge in dieser Zeit nicht vollständig schließt, benötigen Sie Tropfen, Gel und nachts einen Augenverband (Uhrglasverband), um eine Austrocknung des Auges zu verhindern.
- **Dauerhaft vermindertes Gefühl am Ohrläppchen** — Der Nerv, der das Ohrläppchen sensibel versorgt (Nervus auricularis magnus), wird bei den meisten Operationen in Mitleidenschaft gezogen. Das Taubheitsgefühl nimmt bei den meisten Patienten mit der Zeit ab, ein gewisses vermindertes Gefühl am Ohrläppchen und in seiner Umgebung kann jedoch **dauerhaft** bestehen bleiben. Dies beeinträchtigt den Alltag in der Regel nicht.
- **Frey-Syndrom (Schwitzen beim Essen)** — Schwitzen und Rötung der Wange auf der operierten Seite beim Essen. Obwohl es mit Tests häufiger nachweisbar ist, wird es bei etwa **10–20 von 100** Patienten bemerkt und beginnt meist erst Monate später. Wenn es stört, kann es mit schweißhemmenden Cremes oder Injektionen von **Botulinumtoxin** behandelt werden.
- **Einsenkung im Wangenbereich** — Je nachdem, wie viel Gewebe entfernt wird, kann eine leichte Mulde vor dem Ohr und ein Unterschied zwischen beiden Seiten entstehen. Ist dies deutlich sichtbar, kann es mit Eigenfett oder Filler ausgeglichen werden.

Gelegentliche Beschwerden

- **Flüssigkeitsansammlung (Serom) oder Speichelansammlung (Sialozele) / Speichelfistel** — Bei etwa **5–10 von 100** Patienten kann sich im Operationsgebiet Flüssigkeit oder Speichel ansammeln; selten tritt sie durch die Haut nach außen (Fistel). Dies klingt meist innerhalb weniger Wochen durch Punktion mit einer Nadel, einen Druckverband und bei Bedarf Botulinumtoxin ab.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Nachblutung und Bluterguss (Hämatom)** — Bei etwa **1–3 von 100** Patienten kann sich Blut unter der Haut ansammeln. Ist die Ansammlung groß, muss sie unter Umständen im Operationssaal ausgeräumt und die Blutung gestillt werden.
- **Wundinfektion** — Tritt bei **1–3 von 100** Patienten auf; sie heilt meist mit Antibiotika ab, selten ist eine Eiterentleerung (Drainage) erforderlich.
- **First-Bite-Syndrom (Schmerz beim ersten Bissen)** — Insbesondere nach Operationen am tiefen Drüsenanteil ein scharfer, einige Sekunden anhaltender Schmerz am Kieferwinkel bei den ersten Bissen einer Mahlzeit. Er lässt meist mit der Zeit nach.
- **Wiederauftreten des Knotens** — Auch wenn dies bei gutartigen Tumoren selten ist, kann der Knoten im selben Bereich erneut auftreten, oder beim Warthin-Tumor kann sich ein neuer Herd bilden; dies kann eine erneute Operation erforderlich machen. Bei Wiederholungsoperationen ist das Risiko für den Gesichtsnerv höher.
- **Verdickte Narbe oder Keloid** — Je nach individueller Veranlagung kann sich die Narbe verdicken; Kortisoninjektionen oder andere Narbenbehandlungen können eingesetzt werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Dauerhafte Lähmung des Gesichtsnervs** — Bei gutartigen Tumoren kann bei der Erstoperation bei etwa **1–3 von 100** Patienten eine dauerhafte Schwäche eines Astes des Gesichtsnervs oder selten des gesamten Nervs zurückbleiben. Dies kann zu einem herabhängenden Mundwinkel, unvollständigem Augenschluss, einem asymmetrischen Lächeln und trockenem Auge führen; wird das Auge nicht geschützt, können eine Schädigung der durchsichtigen vorderen Augenoberfläche (Hornhaut) und ein Sehverlust auftreten. Das Risiko ist bei bösartigen Tumoren, Wiederholungsoperationen und am Nerv anhaftenden Knoten höher. Entwickelt sich eine dauerhafte Lähmung, können weitere Behandlungen wie augenschützende Medikamente, ein Lidgewicht, eine Nervenrekonstruktion oder Operationen zur Wiederherstellung der Gesichtsbeweglichkeit (Facialis-Reanimation) erforderlich sein.
- **Endgültiger feingeweblicher Befund weicht von der vorläufigen Diagnose ab** — Auch wenn die Voruntersuchungen auf einen gutartigen Knoten hindeuten, kann der endgültige feingewebliche Befund einen **bösartigen** Tumor zeigen. In diesem Fall können eine weitere Operation (Entfernung der restlichen Drüse oder der Halslymphknoten), eine Strahlentherapie oder andere Behandlungen erforderlich sein.
- **Großer Bluterguss am Hals mit Beeinträchtigung der Atemwege** — Sehr selten kann eine sich rasch vergrößernde Blutansammlung auf den Hals drücken und Schluck- oder Atembeschwerden verursachen. Dies ist ein Notfall: Sie muss sofort im Operationssaal ausgeräumt werden, und selten muss der Atemweg gesichert werden (Intubation oder Luftröhrenschnitt/Tracheotomie).
- **Durchblutungsstörungen der Haut** — Aufgehen des Wundrandes, insbesondere unterhalb des Ohrläppchens, infolge einer verminderten Hautdurchblutung; häufiger bei Raucherinnen und Rauchern.
- **Veränderung der Form des Ohrläppchens oder Gefühlsstörung der Ohrmuschel** — Selten; bedingt durch den Hautschnitt oder eine Beeinträchtigung des Nervs.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Rasch zunehmende Schwellung an Hals oder Wange**, insbesondere mit Schluck- oder Atembeschwerden (Notfall – rufen Sie die 112 an)
- **Nicht aufhörende Blutung** aus der Drainage oder der Wunde
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Schmerzen, Überwärmung oder Eiter aus der Wunde
- **Neue oder zunehmende Schwäche** der Gesichtsbewegungen
- Wenn Sie Ihr Auge nicht vollständig schließen können: **Rötung, Fremdkörpergefühl, Schmerzen oder verschwommenes Sehen** am Auge
- **Austreten klarer Flüssigkeit** aus der Wunde oder eine weiche Schwellung vor dem Ohr, die immer größer wird

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Halten Sie die Wunde in den ersten 48 Stunden trocken; danach dürfen Sie nach Anweisung kurz lauwarm duschen.
- In den ersten Wochen kann es das Risiko einer Flüssigkeitsansammlung verringern, sehr saure Speisen und Speisen, die den Speichelfluss stark anregen, zu meiden.
- Wenn eine Schwäche des Gesichtsnervs besteht, verwenden Sie tagsüber künstliche Tränen und nachts Augengel und einen Augenverband; schützen Sie Ihr Auge vor Wind und Staub.
- Schützen Sie die Narbe mindestens 6 Monate lang vor der Sonne (Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor).
- Besprechen Sie das Ergebnis der Pathologie und den weiteren Nachsorgeplan unbedingt mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt; auch bei gutartigen Tumoren werden regelmäßige Kontrollen empfohlen.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Beziehung zwischen dem Gesichtsnerv und dem Knoten erst während der Operation sicher beurteilt werden kann, dass die endgültige Diagnose nach der Operation durch die Pathologie gestellt wird und dass je nach Ergebnis eine weitere Behandlung erforderlich sein kann.
- ☐ Vor der Operation wurde mit mir besprochen, was mit dem Nerv geschehen soll, falls der Tumor in den Gesichtsnerv hineingewachsen ist, und meine Entscheidung wurde im Abschnitt mit den Patientenangaben festgehalten.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.